

健康増進と障害者福祉

環境労働衛生学 加藤沙耶香

本講義のゴール①（健康増進）

GE: 総合的に患者・生活者をみる姿勢 患者の抱える問題を臓器横断的に捉えた上で、心理社会的背景も踏まえ、ニーズに応じて柔軟に自身の専門領域にとどまらずに診療を行い、個人と社会のウェルビーイングを実現する。

GE-02: 地域の視点とアプローチ 地域の実情に応じた医療・保健・福祉・介護の現状及び課題を理解し、医療の基本としてのプライマリ・ケアの実践、ヘルスケアシステムの質の向上に貢献するための能力を獲得する。

GE-02-02: 地域におけるプライマリ・ケア

GE-02-02-05 地域の住民や医療を提供する上で必要となる専門職と協働した地域の健康増進活動の意義の概要を理解している。

1. 健康増進施策の意義を説明できる
2. 健康日本21（第三次）の基本的方向を説明できる
3. 医療者が保健・福祉につなぐ場面を判断できる

本講義のゴール②

SO: 社会における医療の役割の理解 医療は社会の一部であるという認識を持ち、経済的な観点・地域性の視点・国際的な視野等も持ちながら、公正な医療を提供し、健康の代弁者として公衆衛生の向上に努める。

SO-01: 社会保障 憲法で定められた「生存権」を守る社会保障制度、公衆衛生とは何か、地域保健、産業保健、健康危機管理を理解する。保健統計の意義や利用法を学ぶ。

SO-01-02: 社会保険、公的扶助、社会福祉

SO-01-02-03 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)等の障害者福祉の概要を理解している。

SO-01-03: 地域保健

SO-01-03-02 健康増進法、栄養、身体活動、休養等の健康増進施策の意義と概要を理解している。

1. 障害者総合支援法の対象と支援の大枠を説明できる
2. ICFを用いて生活機能と環境因子を整理できる
3. 医師意見書で支援ニーズを具体的に記載できる

健康増進（Health Promotion）

- 一次予防活動の総称。生活習慣の改善や生活環境を整えて、より健康状態を改善させる予防活動のこと。
- 疾病の予防対策
 - 一次予防 健康を増進し発病を予防する
 - 二次予防 病気を早期に発見し早期に治療する
 - 三次予防 病気にかかった後の対応として治療・機能回復・機能維持を行う

健康増進の概念と歴史

- 1946（昭和21）年

世界保健機関（WHO）

健康の定義

「健康とは単に病気でない、虚弱でないというのみならず、
身体的、精神的そして社会的に完全に良好な状態を指す」

1950年代

感染症予防における一般的抵抗力の強化や、健康教育によって
感染機会を避けること

健康増進の歴史（1970年代）

健康増進

健康（疾病と対比した理想的な状態）を更に増強すること

『ラロンド報告』

1974（昭和49）年にカナダのラロンド保健大臣が発表した報告書

公衆衛生活動 疾病予防 → 健康増進へ

病気の決定要因

単一特定病因論 → 長期にわたる多数の要因
（要因宿主と病因）

健康増進の歴史（1970年代）

『ヘルシー・ピープル（HealthyPeople）』

1979（昭和54）年にアメリカ厚生省より打ち出された
国民的健康政策

疫学や健康への危険因子を重視

個人の生活習慣の改善による健康の実現に重点
目標

乳児、子ども、青年と若い成人、成人の4つの違った年齢層の死亡率の
引き下げ

高齢者の自立

科学的に立証された数値目標を人生の年代別で設定 → 国民運動

健康増進の歴史（1980年代）

『オタワ憲章』

1986（昭和61）年

カナダのオタワで開催されたWHOの国際会議

ヘルス・フォー・オールを達成するための行動指針

「ヘルスプロモーションに関するオタワ憲章」

ヘルスプロモーション

人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセス

健康の前提条件

平和、教育、食料、環境等について安定した基盤が必要である

社会的環境の改善をむ



国内における健康 増進活動の今 －健康日本21－

国内における健康増進活動の歴史

.....

■国民健康体力づくり運動（1964-1977）

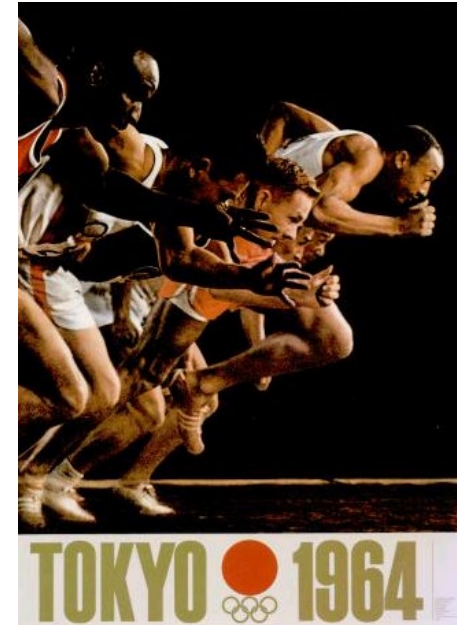
- ・国をあげての健康づくり対策

■第1次国民健康づくり対策（1978-1987）

- ・成人病（生活習慣病）が唱えられる。
- ・市町村保健センターが全国で設立
- ・健康診断体制の充実、バランスのとれた食生活確保

■第2次国民健康づくり対策（1988-1997）

- ・アクティブ80ヘルスプラン（運動面からの施策）
- ・長寿社会における健康作り
- ・保健婦・栄養士のマンパワー確保
- ・「運動・栄養・休養」の3本柱提唱



健康増進法の制定（2002年公布）

- 2000年制定、2002年公布
- 「21世紀における国民健康づくり運動」（健康日本21）を具体化する法律
- 医療制度改革の一環で、廃止された栄養改善法の内容も統合。
- 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行

<主なポイント>

- ・ **第7条 基本方針の策定（健康日本21）**： 厚生労働大臣は、国民の健康増進の総合的な推進を図る基本方針を定める
- ・ **第9条 健康診査等指針の策定**： 厚生労働大臣は、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳の交付等の措置に関して健康診査実施等に関する指針(健康診査等指針という)を定める
- ・ **第10条 国民健康・栄養調査**： 国民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況把握のため、国民健康・栄養調査を行う
- ・ **第16条 生活習慣病の発生状況の把握**： 国民の生活習慣とがん、循環器病等の生活習慣病の発生状況の把握に努める
- ・ **第16条の2 食事摂取基準**： 食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定める
- ・ **第25条～42条 受動喫煙の防止**： 望まない受動喫煙が生じないように、受動喫煙の知識の普及、受動喫煙防止の意識啓発、受動喫煙防止に必要な環境整備等の措置を講ずるよう努めなければならない
- ・ **第43条：特別用途表示の許可**： 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(特別用途表示)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない（消費者庁長官に権限を委任）

健康日本21の概要



■ 目的

- ・平均寿命の延伸はすでに実現
①壮年期死亡の減少、②健康寿命の延伸、③生活の質向上

■ 2000年～：第3次国民健康づくり（健康日本21）

10年間を目途とした具体目標を提示、健康に関連する全ての関係機関・団体、国民が一体となった健康づくり運動を総合的に推進（2006年に中間評価）。

■ 2013年～：第4次国民健康づくり（健康日本21（第二次））

<基本方針：5本柱>

- ① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
- ② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（非感染性疾患予防）
- ③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
- ④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
- ⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

■ 2024年～：二十一世紀における第三次国民健康づくり運動 （健康日本 21（第三次））



② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

- a:改善している**
- ・ 75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少*
 - ・ がん検診の受診率の向上*
 - ・ 脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少
 - ・ 高血圧の改善
 - ・ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上*
 - ・ 血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少
- b:変わらない**
- ・ 脂質異常症の減少
 - ・ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少
 - ・ 糖尿病合併症(糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数)の減少
 - ・ 糖尿病の治療継続者の割合の増加
 - ・ 糖尿病有病者の増加の抑制
 - ・ COPDの認知度の向上

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

- a:改善している**
- ・ 自殺者の減少
 - ・ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加*
 - ・ 小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加
 - ・ 健康な生活習慣(栄養・食生活、運動)を有する子どもの割合の増加*
 - ・ ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加
 - ・ 低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制
 - ・ 足腰に痛みのある高齢者の割合の減少*
- b:変わらない**
- ・ 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少
 - ・ 適正体重の子どもの増加
 - ・ 介護保険サービス利用者の増加の抑制
 - ・ 高齢者の社会参加の促進(就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加)
- d:評価困難**
- ・ 認知機能低下・ハイリスク高齢者の把握率の向上

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備

- a:改善している**
- ・ 地域のつながりの強化
 - ・ 健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加
 - ・ 健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点数の増加
 - ・ 健康格差対策に取り組む自治体の増加
- b:変わらない**
- ・ 健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

健康日本21（第二次）
策定時(2010年前後)と
直近値（2016年前後）
での達成状況

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

栄養・食生活	身体活動・運動	休養	飲酒	喫煙	歯・口腔の健康
a:改善している ・ 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加 ・ 利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合の増加*	a:改善している ・ 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加	a:改善している ・ 週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少*	a:改善している ・ 未成年者の飲酒をなくす ・ 妊娠中の飲酒をなくす*	a:改善している ・ 成人の喫煙率の減少* ・ 未成年者の喫煙をなくす ・ 妊娠中の喫煙をなくす* ・ 受動喫煙の機会を有する者の割合の減少*	a:改善している ・ 歯の喪失防止 ・ 乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 ・ 過去1年間に歯科検診を受診した者の割合の増加
b:変わらない ・ 適正体重を維持している者の増加 ・ 適切な量と質の食事をとる者の増加 ・ 共食の増加	b:変わらない ・ 日常生活における歩数の増加 ・ 運動習慣者の割合の増加	b:変わらない ・ 睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少	b:変わらない ・ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少		b:変わらない ・ 口腔機能の維持・向上
					c:悪化した ・ 歯周病を有する者の割合の減少

健康日本21（第二次） 最終評価

健康日本21（第二次） 最終評価 53項目の評価のまとめ

策定時のベースライン値と直近の実績値を比較	項目数 (再掲除く)
A 目標値に達した	8 (15.1%)
B 現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある	20 (37.7%)
C 変わらない	14 (26.4%)
D 悪化している	4 (7.5%)
E 評価困難	7 (13.2%)
合計	53 (100.0%)

	＜基本的な方向※＞					
評価	1	2	3	4	5	全体
A	1 <50.0%> (1.9%)	3 <25.0%> (5.7%)	3 <25.0%> (5.7%)		1 <4.5%> (1.9%)	8 (15.1%)
B		3 <25.0%> (5.7%)	4 <33.4%> (7.5%)	2 <40.0%> (3.8%)	11 <50.0%> (20.8%)	20 (37.7%)
C	1 <50.0%> (1.9%)	4 <33.3%> (7.5%)	3 <25.0%> (5.6%)	1 <20.0%> (1.9%)	5 <22.7%> (9.4%)	14 (26.4%)
D		1 <8.3%> (1.9%)	1 <8.3%> (1.9%)		2 <9.1%> (3.8%)	4 (7.5%)
E		1 <8.3%> (1.9%)	1 <8.3%> (1.9%)	2 <40.0%> (3.8%)	3 <13.6%> (5.7%)	7 (13.2%)
合計	2 <100%> (3.8%)	12 <100%> (22.6%)	12 <100%> (22.6%)	5 <100%> (9.4%)	22 <100%> (41.5%)	53

目標値に達した項目（A）	悪化している項目（D）
健康寿命の延伸（日常生活に制限のない期間の平均の延伸）	メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少
75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（10万人当たり）	適正体重の子どもの増加
脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少（10万人当たり）	睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少
血糖コントロール指標におけるコントロール不者の割合の減少 （HbA1cがJDS値8.0%（NGSP値8.4%）以上の者の割合の減少）	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（一日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上の者）の割合の減少
小児人口10万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加	
認知症サポーター数の増加	
低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の増加の抑制	
共食の増加（食事を1人で食べる子どもの割合の減少）	

（※）基本的な方向

- 1：健康寿命の延伸と健康格差の縮小
- 2：生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
- 3：社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
- 4：健康を支え、守るための社会環境の整備
- 5：栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

共食の増加 (食事を1人で食べる子どもの割合の減少)

【背景】

国内外の研究で家族との共食頻度が低い児童生徒で肥満・過体重が多い。

日本 孤食頻度が高い中学生は、自覚的症状の訴えが多い

共食頻度が高い者は、野菜・果物・ご飯を「よく食べる」者が多い等、食物摂取状況が良好な傾向。

欧米 共食頻度が高い児童・生徒ほど、野菜・果物摂取量が多く、清涼飲料水の摂取量が少なく、ビタミン、ミネラルの摂取量が多い。

思春期の共食頻度の高さがその後の食物摂取状況とも関連する。

学童・思春期の共食を推進→健康状態及び栄養素等摂取量の改善、食習慣の確立

共食の増加 (食事を1人で食べる子どもの割合の減少)

【今回の評価】

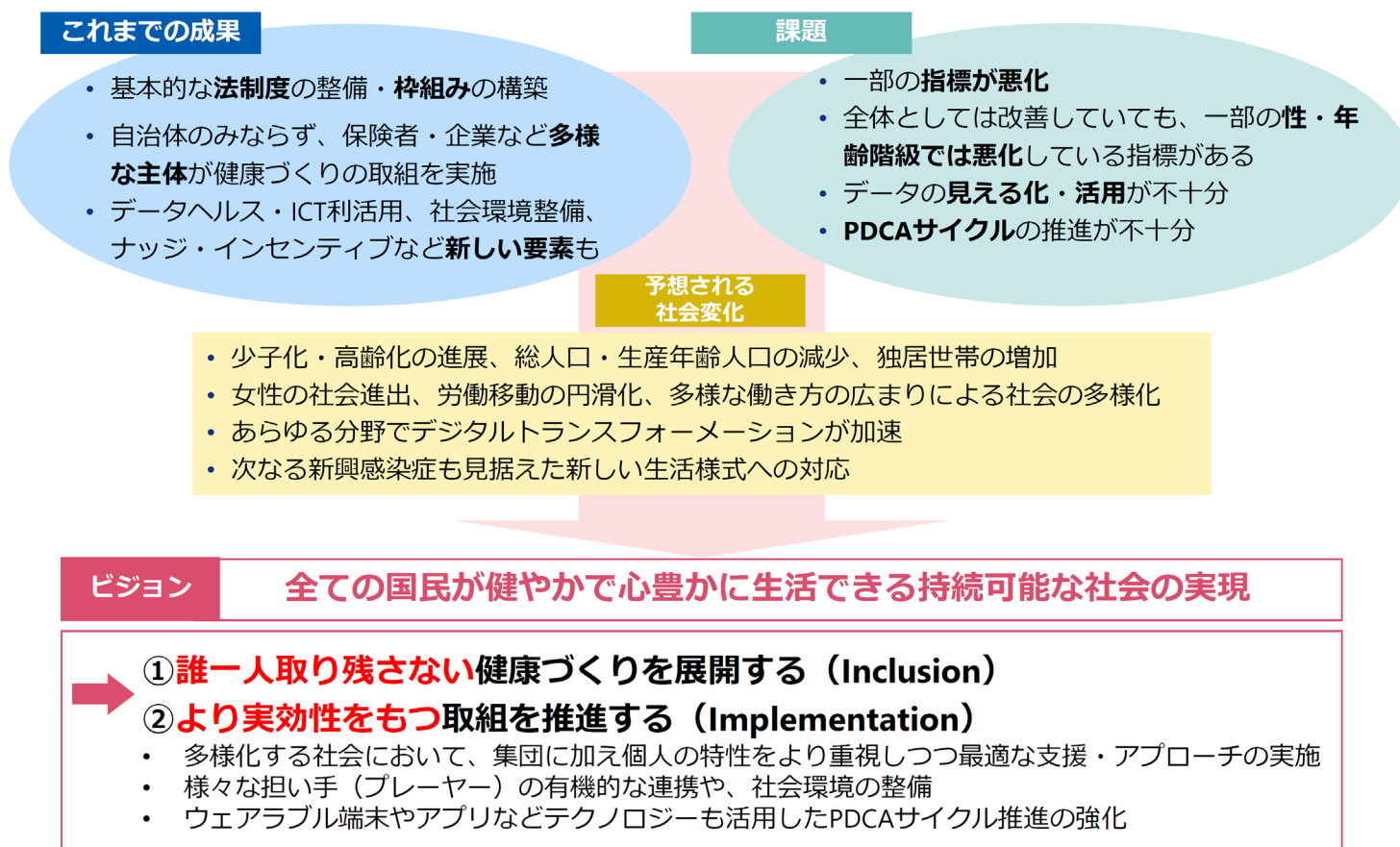
食事を1人で食べる子どもの割合
(ベースラインの平成22(2010)年度との比較)

朝食	中間評価	最終評価	相対的变化
小学生	15.3%	12.1%	-20.9%
中学生	33.7%	28.8%	-14.5%

夕食	中間評価	最終評価	相対的变化
小学生	2.2%	1.6%	-27.3%
中学生	6.0%	4.3%%	-28.3%

健康日本21（第3次）

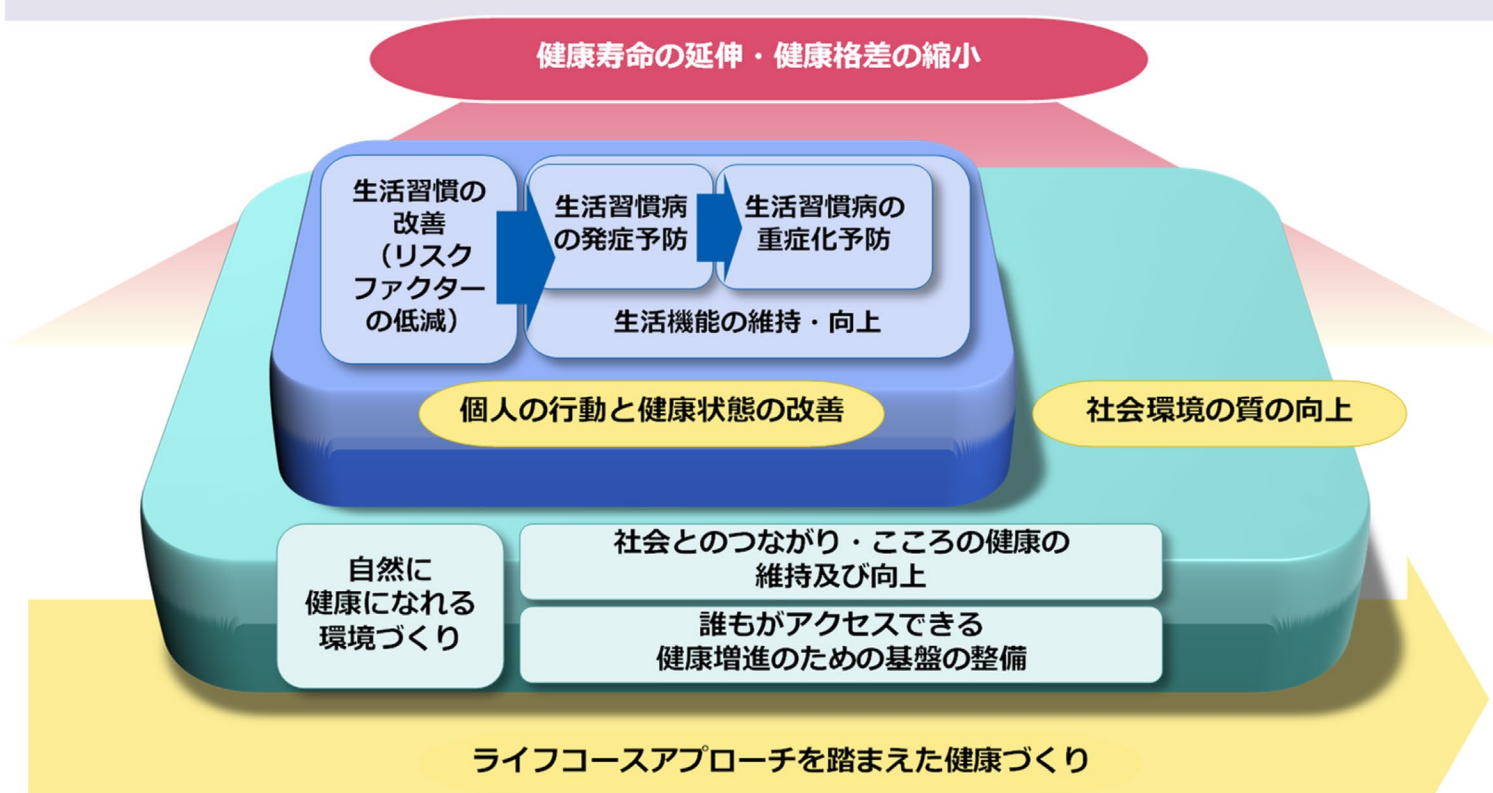
図表1：健康日本21（第三次）のビジョン



健康日本21（第3次）

図表 2：健康日本 21（第三次）の概念図

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める



医療者が見るポイント

- ・生活習慣だけでなく、社会環境を見る
- ・疾患を持つ人も健康づくりの対象である
- ・胎児期から高齢期まで、時間軸で健康を考える

● 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

- すべての国民が健やかに生活できる持続可能な社会の実現を目指す
- 個人の行動・健康状態の改善だけでなく、社会環境の整備とその質の向上が重要
- 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を同時に図る

● 個人の行動と健康状態の改善

- 栄養・運動・休養・飲酒・喫煙・口腔ケアなどの生活習慣を改善
- がんや生活習慣病（NCDs）の発症・重症化を予防
- 口コミ、やせ、メンタル不調などの生活機能低下も予防対象
- 疾患を抱える人も含めた「誰一人取り残さない」健康支援
- 「生活習慣病」という用語の使い方にも社会的配慮が必要

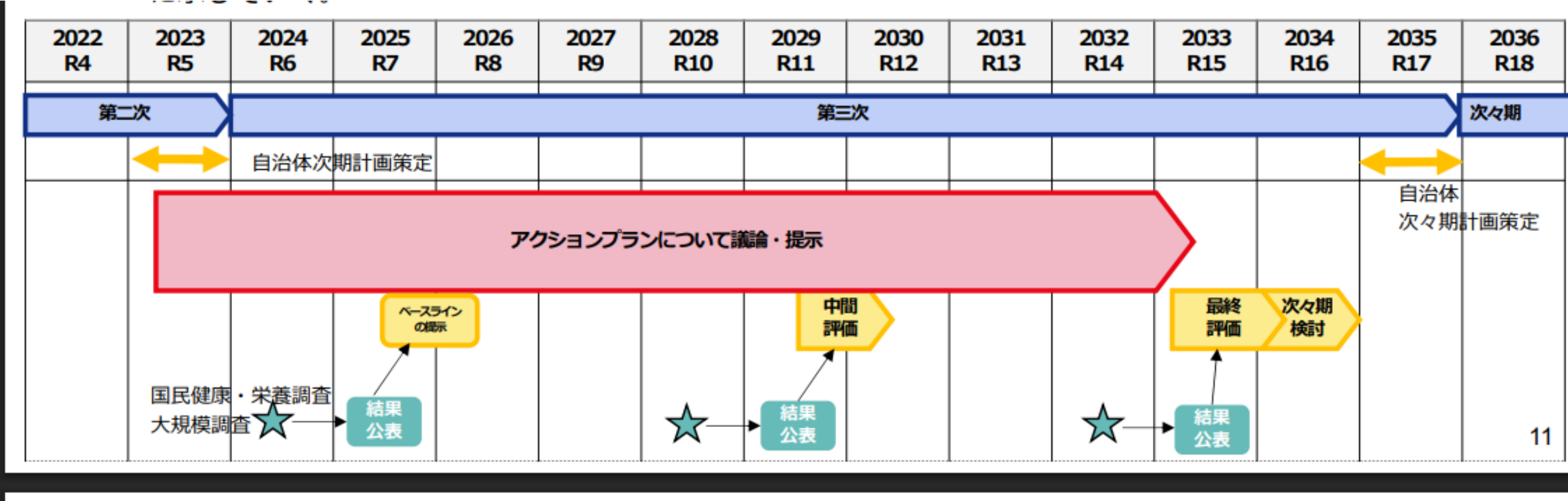
● 社会環境の質の向上

- 就労・ボランティア・通いの場など、社会参加の機会を拡充
- つながりや居場所の確保、こころの健康を支える環境整備
- 自然に健康になれる環境（食・運動・まちづくり）を推進
- PHR（パーソナル・ヘルス・レコード）など健康情報へのアクセスを整備
- 誰もが利用できる保健・医療・福祉サービス基盤の強化

● ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

- 胎児期から高齢期まで、すべてのライフステージに応じた健康支援
- 現在の健康状態は過去の生活や社会環境の影響を受ける
- 健康づくりは次世代にも影響する視点が重要
- 計画的・連携的に経時的な支援を展開する

健康日本21（第3次）



障害者福祉

知っておきたい基礎概念・理念・用語①

障害の受容の5段階

段 階	概 要
ショック期	障害の発生直後で集中医療を受けている時期。肉体的苦痛はあるが、心理的には平穏で、感情が鈍麻した無関心な状態にあることが多い
否認期	身体的状態が安定すると共に、生物学的な保護反応が消え、心理的な防衛反応としての疾病・障害の否認を生じる時期
混乱期 (怒り、うらみ、悲嘆、抑うつ)	攻撃性が高い時期。外向的に現れるとすべてを他人の責任にし、怒り、恨みの感情をぶつける。内向的に現れると悲嘆、抑うつ、自殺企図を生じる
解決への努力期	前向きの建設的な努力が主になる時期
受容期	社会（家庭）のなかで新しい役割や仕事を得て、活動をはじめ、生きがいを感じるようになる時期

(上田敏「障害の受容－その本質と諸段階について－、総合リハ、1980)

G13 障害の受容について正しいのはどれか

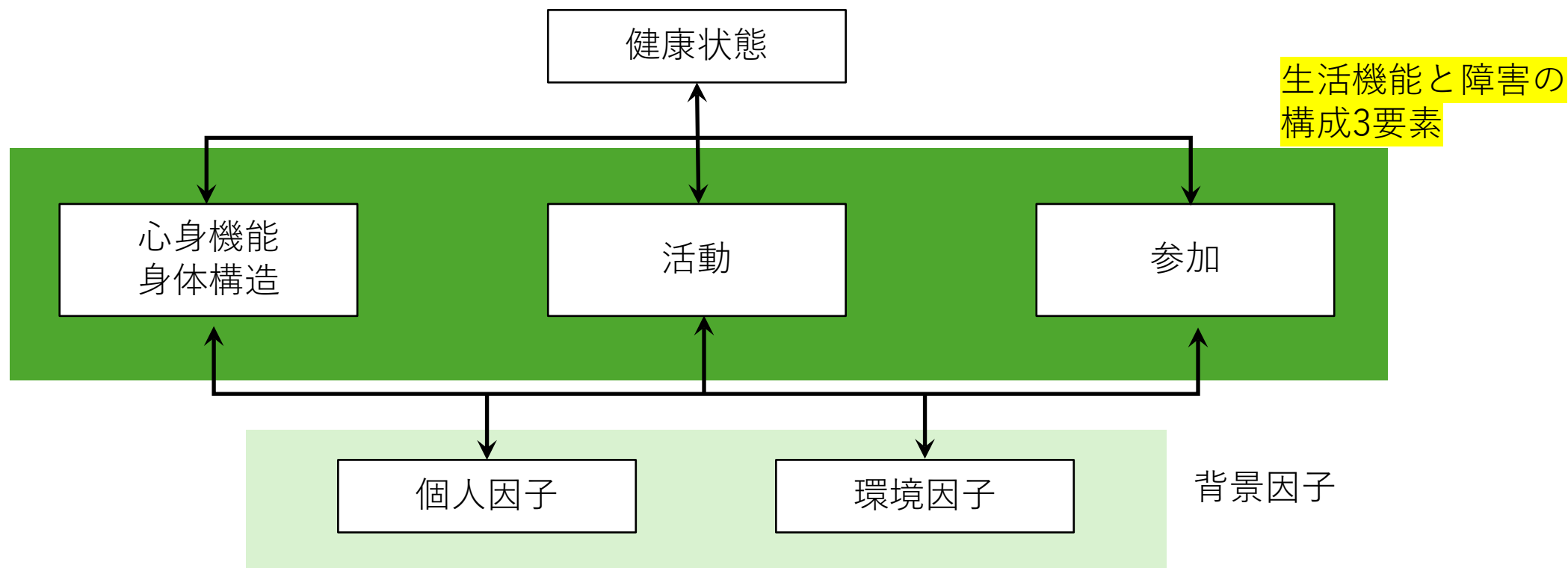
- a ショック期では、感情が抑制されやすい
- b 否認期では、自己の障害の理解が重要である
- c 混乱期では、抑うつ的になることはまれである
- d 悲観期では、家族の強い励ましが必要である
- e いったん受容に至れば、障害受容は完成する

(平成24年 第106回医師国家試験問題より)

知っておきたい基礎概念・理念・用語②

国際生活機能分類

(ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, 2001)



C3 国際生活機能分類（ICF）の「生活機能と障害」の構成要素に含まれないのはどれか。

- a 活動
- b 環境
- c 参加
- d 心身機能
- e 身体構造

（平成31年 第113回医師国家試験問題より）

G38 歩行障害のため普段は車椅子で職場へ通勤している人が、車椅子が故障したため仕事を休んだ。この人の生活機能を国際生活機能分類で評価した場合、普段とは評価が異なる項目はどれか。3つ選べ。

- a 活動制限
- b 環境因子
- c 機能障害
- d 参加制約
- e 身体構造

(平成25年 第107回医師国家試験問題より)

障害者福祉と三次予防

- 重症化予防のための適切な治療
- 社会復帰を測るためのリハビリテーション

社会復帰を測るためのリハビリテーション

- 残された能力を「最大限に活用させ、ノーマライゼーションをはかる。
- 医学的側面と同時に心理的・社会的側面および職業的側面を持っている。
- 社会的な援助として、障害者雇用促進法、介護保険による機能訓練、身体障害者補装具費の援助などが挙げられる

知っておきたい基礎概念・理念・用語③

ノーマライゼーション (Normalization)

「障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会を目指すという理念（厚生労働省の定義）」

Normalization = 「標準化・正常化・常態化」という意味。「以前は特異とされていたことがあたりまえの状態になっていること」を指す。「障害がある人を変える」のではなく、彼ら／彼女らがありのままで健常者とともに生活ができるように「周りが変わる」という視点も含まれる。

- 1959年：デンマークの法律として成立（N・E・バンク-ミケルセンという行政官が提唱）
- 1969年：スウェーデン知的障害児者連盟会長ベクト・ニリエがノーマライゼーションの理念を整理し、翻訳・発表。米国に広めたことで1970年代以降、世界中に普及。
- 1975年：「障害者の権利宣言」が国連で採択（ノーマライゼーションの理念が反映）
- 1981年：障害者の権利宣言を実現するために「国際障害者年」と定め、1983年からの10年間を「国連障害者の10年」と宣言した
- 1993年：国内で「障害者基本法」が制定
- 1996年：国内で「障害者プラン(ノーマライゼーション7か年戦略)」が策定

知っておきたい基礎概念・理念・用語④

ユニバーサルデザイン、バリアフリー、アクセシビリティ

- バリアフリー(barrier free) : 高齢の人や障害のある人が社会への関わりを持とうとしていくときに、社会の側でそれを妨げてしまう現実があるとの認識のもとに、その妨げるものを障壁（バリア）と呼んで、バリアをなくすようにする設計のこと
- アクセシビリティ(accessibility) : バリアフリーと同義。国際的には「バリアフリー」はあまり用いない。アクセシビリティまたはアクセシブル・デザイン（accessible design）の方が主流
- ユニバーサルデザイン（Universal design） : 最初から女性、子供、高齢者、障害者など、様々な人ができるだけ使えるように製品、建物、環境を設計初期段階から配慮すること。「全ての年齢や能力の人々に対し、可能な限り最大限に使いやすい製品や環境のデザイン」の総称。
* 米国建築家・プロダクトデザイナーのRonald L. Mace (1941-1998)が提唱

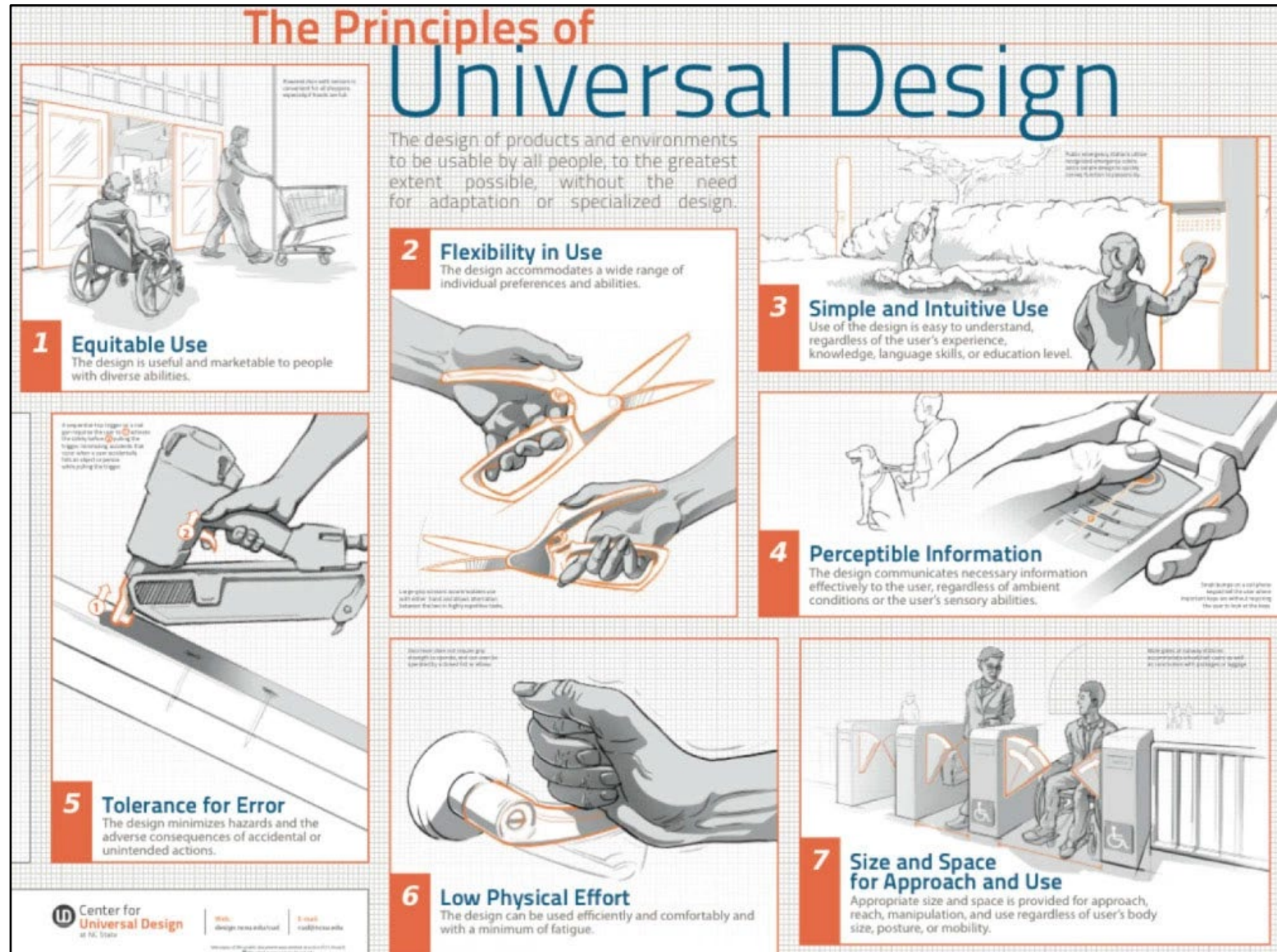
バリアフリーとユニバーサルデザインの特徴

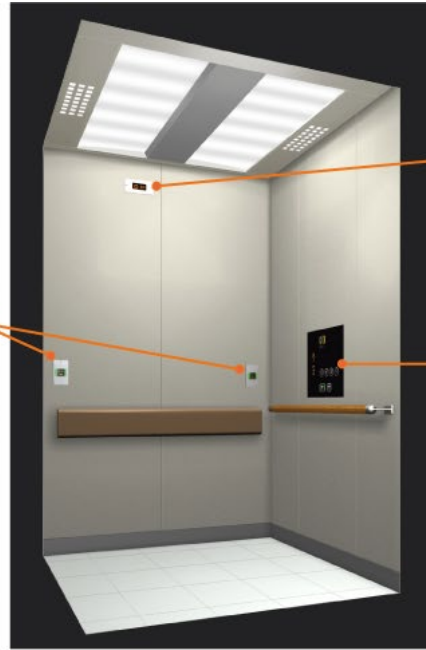
	Barrier Free	Universal Design
語彙	障害(barrier)を取り除く(free)	普遍的な、一般的な
パラダイム	現実対応的	理想志向的
着手時期	事後対応 (既存製品のアクセシビリティ担保)	事前対応 (設計時から考慮)
アプローチ	個別対応 (各々の障害特性に合わせた対応)	製品の柔軟性対応 (ある程度利用されるユーザを想定した設計)
製品形態	福祉機器・支援機器	一般製品
開発・製造	(主に) サードパーティ	メーカー自身
ターゲット	特定ユーザにのみ恩恵	幅広いユーザ層に恩恵

ユニバーサルデザイン7原則

1. 誰でも公平に使えること
2. 使う上での自由度が高いこと
3. 使いかたが簡単で、直感的に理解できること
4. 必要な情報がすぐに見つかること
5. うっかりミスや危険につながらないこと
6. 身体への負担が軽く、楽に使えること
7. 接近したり利用するために十分な大きさと広さが確保されていること

“Principles of Universal Design”, NC State University, The Center for Universal Design









E37 ユニバーサルデザインについて正しいのはどれか。3つ選べ。

- a 日用品は対象である
- b 長時間使っても疲れない
- c 知的障害者は対象ではない
- d 利用者の適応能力が求められる
- e うっかりミスが危険につながりにくい

(平成25年 第107回医師国家試験問題より)

F29 ユニバーサルデザインの例として適切なのはどれか。

- a 回転ドアの設置
- b 地下歩道の整備
- c エレベーターの設置
- d エスカレーターを設置
- e 障害者（児）施設の設置

（平成30年 第112回医師国家試験問題より）

知っておきたい基礎概念・理念・用語⑤

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



SDGs
(持続可能な開発目標)

障害者総合支援法（2013年～）

.....

- 障がい者への福祉サービスは、障害の種別により法律が整備されてきたため、縦割りによる弊害も生み出していた。各種サービスの一元化と利用者本位のサービス供給体制の確立を目的に2005年には「障害者自立支援法」が成立。

＊所得に応じた負担ではなく、受益負担へ変更した事への批判から廃止を含めて検討

- 同法を一部改正し、「障害者総合支援法」として2013年に新たに施行

<主なポイント>

第4条 障害者・児の定義

- ・対象者（障害者）：18歳以上の身体障害、知的障害、精神障害（発達障害含む）および難病患者
- ・対象者（障害児）：18歳未満の障害のある児童

第6条～26条 自立支援給付（障害の種類にかかわらず全国一律に給付される障害福祉サービス）

第77条～78条 地域生活支援事業

第92条～96条 費用負担

地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

(平成24年6月20日 成立・同年6月27日 公布)

1. 趣旨

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

2. 概要

1. 題名

「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。

2. 基本理念

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。

3. 障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)

「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

4. 障害支援区分の創設

「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。

※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

5. 障害者に対する支援

- ① 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
- ② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
- ③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)
- ④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

6. サービス基盤の計画的整備

- ① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定
- ② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
- ③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
- ④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

3. 施行期日

平成25年4月1日(ただし、4. 及び5. ①～③については、平成26年4月1日)

4. 検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)

- ① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
 - ② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
 - ③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
 - ④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方
 - ⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
- ※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

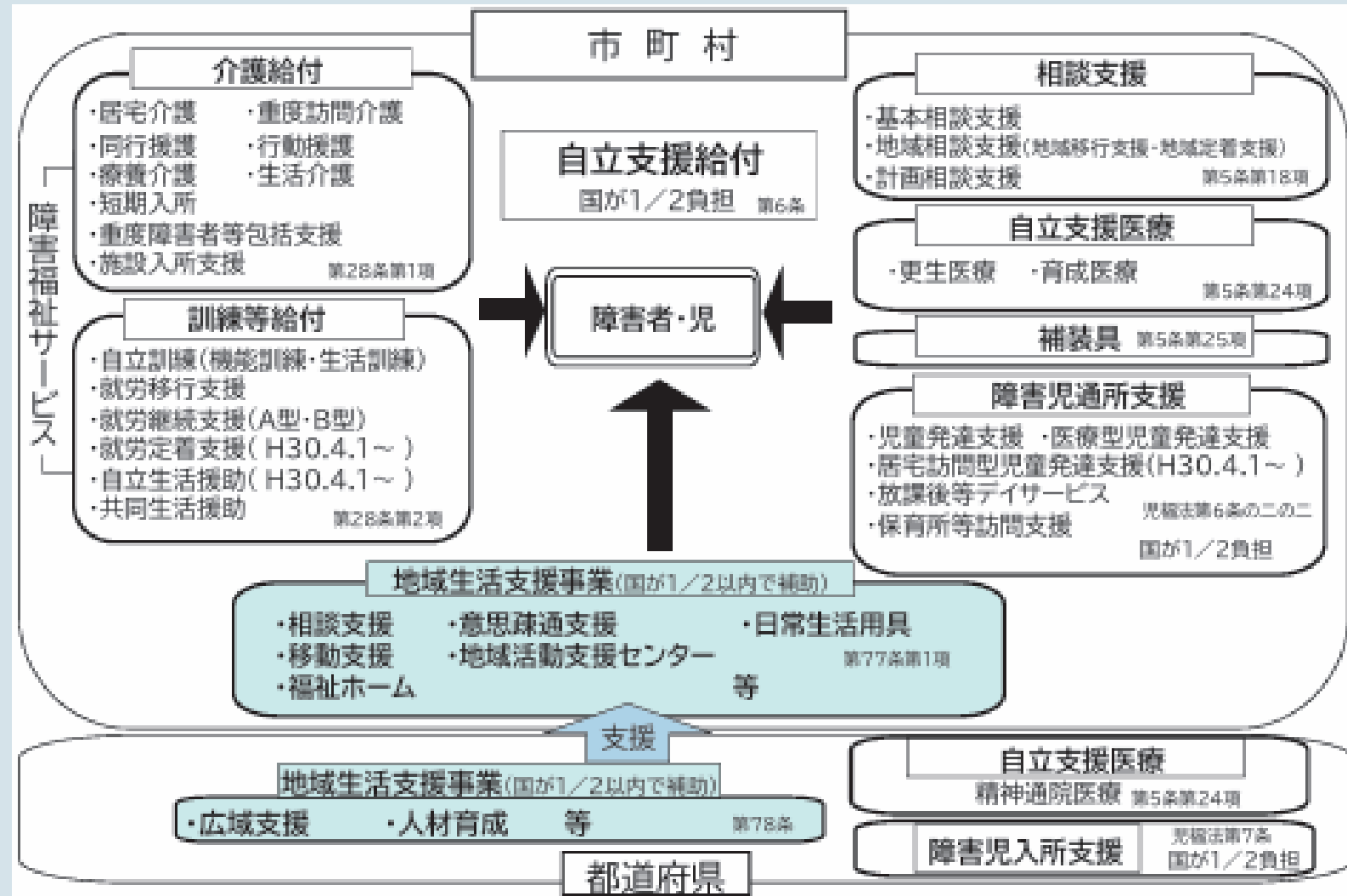
障害者総合支援法

障害者総合支援法の対象者

- ・ 身体障害者
- ・ 知的障害者
- ・ 精神障害者（発達障害者を含む）
- ・ 満18歳に満たない身体・知的・精神に障害のある児童（発達障害者を含む）
- ・ 政令で定める難病等により障害がある者で18歳以上のもの

図表 2-1-4

障害者総合支援法に基づく給付・事業



障害者支援の考え方と障害支援区分

○「障害」の概念の変化

医学モデル

「障害」とは、個人の心身機能の障害によるもの



社会モデル

「障害」とは、社会（モノ、環境、人的環境等）と心身機能の障害がいまって作りだされているもの

○障害者支援の基本理念

自らの生き方、暮らし方を選択し、実現できる「自己決定」

「自己実現」

（参考）第4次障害者基本計画（抜粋）「Ⅱ 基本的な考え方」基本理念

（中略）障害者を，必要な支援を受けながら，自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ，障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援する（中略）

→障害支援区分はどこに住んでも平等に公平にサービスを利用できるようにするための指標

「障害支援区分」と「要介護度」の主な考え方の違い

	障害支援区分	要介護度
区分	非該当、区分1～6	非該当、要支援1～2、 要介護1～5
区分が示すもの	<u>必要とされる標準的な支援の総合的な度合</u>	<u>介護の手間(介護の時間)の総量</u>
認定調査の考え方	「できたりできなかったりする 場合」は、 <u>「できない状況」に 基づき評価</u>	「できたりできなかったりする 場合」は、 <u>「より頻回な状況」に 基づき評価</u>
審査会の考え方	対象者に必要とされる <u>支援の 度合い</u> が一次判定結果に相 当するか検討	通常に比べ <u>介護の手間</u> がより 「かかる」「かからない」か検討

各サービスと障害支援区分の対応（概略）

	訪問系					日中活動系			施設系	居宅支援系
	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	行動援護	重度障害者等 包括支援	生活介護	短期入所	療養介護	施設入所支援	共同生活援助
非該当			↑			50歳 以上は 区分2 以上				↑
区分1	↑		↑				↑	対象者 は区分 ごとに 別途規 程有り	50歳 以上は 区分3 以上	↑
区分2										
区分3			↑	↑		↑	↑			
区分4		↑		↑		↑	↑		↑	
区分5			↑	↑		↑	↑	↑	↑	
区分6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※上記以外にも利用要件や加算要件、経過措置等があるため、
詳細は各種規程等を確認してください。

25

医師意見書の 位置付け

- 医師意見書は、区分認定の流れの中で、市町村が一次判定（コンピュータ判定）を行う際及び市町村審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」や「特記事項」とともに検討対象となるもの（図参照）。

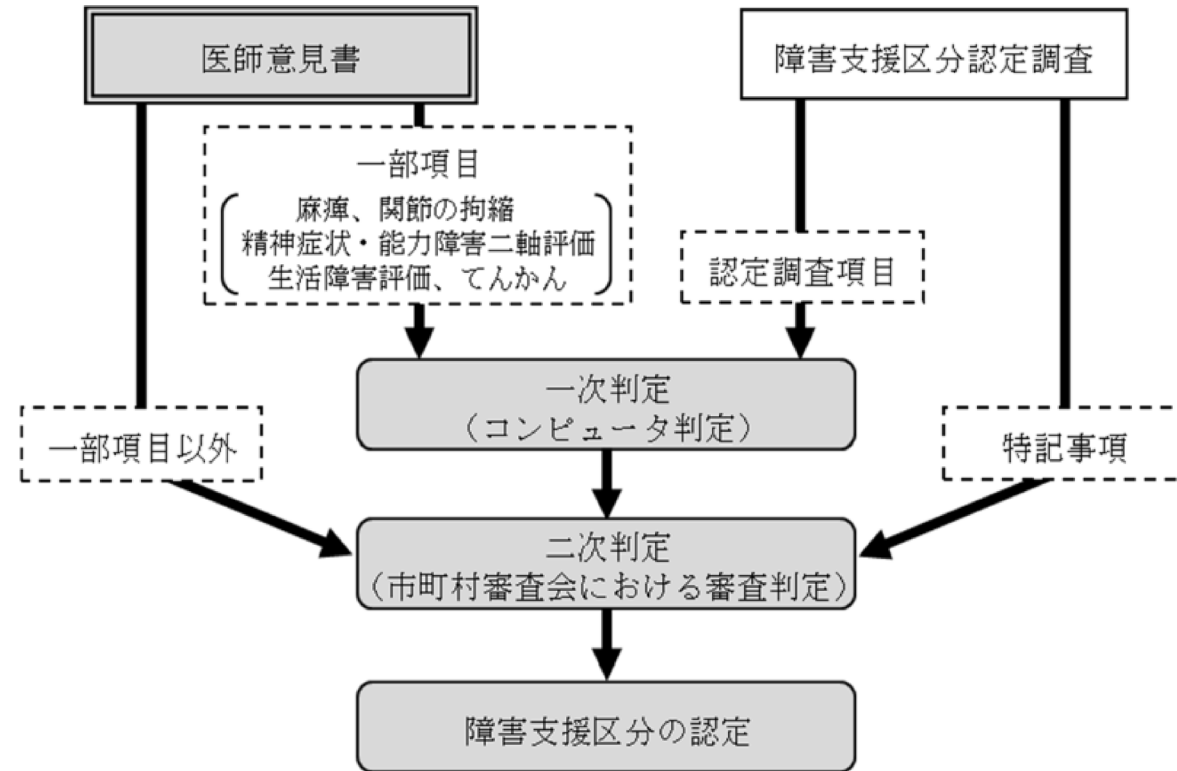


図. 障害支援区分の認定の流れ

出典：障害者総合支援法における障害支援区分
医師意見書記載の手引き（令和3年2月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

医師意見書の利用場面と判定への影響

■ 医師意見書の主な利用場面

- ・ 障害支援区分の支給決定プロセスで使用

1. 一次判定（コンピュータ判定）

- ・ 認定調査＋意見書の一部を元にソフトで自動判定
- ・ 一次判定で活用される「医師意見書の一部項目」

麻痺（左右：上肢、左右：下肢、その他）

関節の拘縮（左右：肩・肘・股・膝関節、その他）

精神症状・能力障害二軸評価（精神症状評価、能力障害評価）

生活障害評価（食事、生活リズム、保清、金銭管理、服薬管理、対人関係、社会的適応を妨げる行動）

てんかん

- **二次判定（市町村審査会）**

- ・ 一次判定を原案として、医師意見書（一次判定で使わなかった項目）や特記事項を総合的に勘案
- ・ 記載内容によって一次判定が修正される場合あり

- 医師意見書の記載に当たっては、**申請者の心身の状況や必要とされる支援の度合い等について、具体的な状況を挙げて記載**

記載の注意点とその他の活用方法

■ 記載時の留意点

- ・心身の状態や支援の必要性を**具体例でわかりやすく**
- ・専門外の調査員の評価を補完・修正できる重要情報

■ その他の利用場面

3. 認定調査結果の確認・修正

- ・主治医の見解に基づき、一次判定をやり直すこともある

4. サービス等利用計画の作成

- ・医師と本人の同意があれば、医学的留意点をサービス提供者に共有可能
- ・意見書冒頭の同意欄に記入のうえ、留意点を**具体的に**記載

医師意見書の役割

赤枠が必須項目

障害の直接の原因となっている傷病名を「1.」に記入

一次判定（コンピュータ判定）において使用される項目

チェック漏れないか特に要確認

医師意見書	
記入日	年 月 日
氏名	（氏名） 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地
職業	（職業） 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地
上記の申請書に添付する意見書は以下の通りです。 主として本書がサービス利用対象者の申請に当たって利用されることに同意する。 □同意する。 □同意しない。 氏名 住所 電話番号 Eメール	
1. 障害に関する意見	（1）障害の原因 □事故 □労務 □その他 （2）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （3）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
2. 障害の直接の原因となっている傷病名を「1.」に記入	（1）障害の原因 □事故 □労務 □その他 （2）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （3）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
3. 障害の程度に関する意見	（1）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （2）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
4. 障害の程度に関する意見	（1）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （2）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
5. 障害の程度に関する意見	（1）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （2）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他

医師意見書	
記入日	年 月 日
氏名	（氏名） 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地
職業	（職業） 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地 〒 市 区 町 丁目 番 号 番地
上記の申請書に添付する意見書は以下の通りです。 主として本書がサービス利用対象者の申請に当たって利用されることに同意する。 □同意する。 □同意しない。 氏名 住所 電話番号 Eメール	
1. 障害に関する意見	（1）障害の原因 □事故 □労務 □その他 （2）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （3）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
2. 障害の直接の原因となっている傷病名を「1.」に記入	（1）障害の原因 □事故 □労務 □その他 （2）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （3）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
3. 障害の程度に関する意見	（1）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （2）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
4. 障害の程度に関する意見	（1）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （2）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他
5. 障害の程度に関する意見	（1）障害の程度 □軽度 □中等 □重度 （2）障害の診断 □内科 □外科 □神経科 □精神科 □皮膚科 □泌尿科 □婦人科 □小児科 □その他

一次判定（コンピュータ判定）において使用される項目

チェック漏れないか特に要確認

医師意見書はGoogle Driveにあるものを使用してください。

事例

【基本情報】

- 氏名：川澄 太郎（かわすみ たろう）
- 年齢：20歳（平成17年5月生まれ）
- 性別：男性
- 同居家族：両親（介護者は主に母）
- 医療機関：桜山神経内科クリニック 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄X-X-X

【診断名・経過】

- 主病名：低酸素性虚血性脳症（出生時の仮死による）
- 合併症：四肢麻痺（痙直型）、てんかん（難治性）、重度知的障害
- 経過：出生直後からNICU管理、1歳頃から経管栄養開始。
現在も自発運動なし、寝たきり。意思表示は表情変化のみ。
- 投薬：抗てんかん薬（バルプロ酸、クロバザム）を2剤併用
- 医療的ケア：胃ろう・喀痰吸引・導尿あり

【身体の状態】

- 利き腕：なし（意思表示・随意運動困難）
- 身長：145cm 体重：30kg（痩身、筋萎縮）
- 麻痺：上下肢すべて重度
- 拘縮：肩・肘・股・膝すべてに重度拘縮あり
- 筋力：全身の筋緊張は高く、痙縮あり
- 関節痛：慢性的な姿勢不良による両股関節および仙腸部痛みあり（対症的に処置）軽程度、過去6ヶ月の症状の変動：なし
- 失調・不随意運動：なし
- 褥瘡：仙骨部に軽度の皮膚損傷（管理中）

【精神・行動・生活機能】

- 意識障害：なし（覚醒・睡眠リズムあり）
- 意思疎通：表情や声による反応がわずかに可能
- 行動上の問題：なし（外的刺激に反応あり）
- 精神症状評価：6（重度）
- 能力障害評価：5（全面介助）
- 生活障害評価：
 - 食事：5（完全経管）
 - 清潔：5（全面介助）
 - 生活リズム：4（昼夜逆転傾向あり）
 - 金銭管理・服薬管理・対人関係：すべて5

【特別な医療的ケア】

- 胃ろう管理：毎食
- 喀痰吸引：1～2時間ごと（昼夜）
- 在宅酸素療法：夜間使用あり
- 間欠的導尿：1日4回程度（母が実施）
- モニター管理：発作時必要時のみ（パルスオキシメーター）
- 定期受診：月1回（神経内科）

【医師としての意見・留意点】

- 今後のリスク：誤嚥性肺炎、てんかん重積、褥瘡悪化
- 対応方針：適切な体位保持、呼吸管理、てんかん予防を継続
- 障害福祉サービス利用時の留意点：
 - ・吸引・経管栄養など医療的ケアへの対応が不可欠
 - ・急変時対応に熟練したスタッフの配置が望ましい
 - ・コミュニケーション支援（表情・反応の理解）が必要
- 感染症：MRSA保菌（病状には影響なし）

障害福祉サービスの利用時に関する医学的観点からの留意事項

- **血圧について：**
特段の高低はないが、脱水や体位変換時の血圧変動に注意。
必要時に血圧測定できる体制が望ましい。
- **嚥下について：**
経管栄養（胃ろう）で管理。経口摂取は行っておらず、誤嚥リスクは少ないが、逆流や痰誤嚥には留意。
- **摂食について：**
全量胃ろうによる栄養補給。注入速度・体位保持に注意。注入中は上体30度以上を保持すること。
- **移動について：**
全介助。ベッド⇔バギー間の移乗時には職員2名による介助が必要。長時間の座位保持は不可。
- **行動障害について：**
特になし。意思表示は声や表情によるわずかな反応のみ。
- **精神症状について：**
安定しているが、睡眠リズムの乱れあり。夜間覚醒・不安定な状態が見られる場合は静穏な対応を希望。
- **その他：**
医療的ケア（喀痰吸引、導尿、胃ろう管理）が必須のため、対応可能なスタッフ体制の整備が不可欠。

障害者総合支援法の対象者が取得できる可能性のある手帳

- 身体障害者→ 身体障害者手帳
- 知的障害者→ 療育手帳
- 精神障害者（発達障害者を含む）→精神障害者保健福祉手帳
- 満18歳に満たない身体・知的・精神に障害のある児童（発達障害者を含む）→上記3つ状況に応じて
- 政令で定める難病等により障害がある者で18歳以上のもの⇒特定医療費（指定難病）受給者証

- 障害者手帳は、障害の状態を公的に確認し、各種支援につなぐための仕組みである。ただし、障害福祉サービスの利用可否は、手帳の有無だけで決まるものではない。
- 手帳がなくても対象になり得る例
 - 難病等
 - 発達障害
 - 精神障害

見るポイント	介護保険	障害者総合支援法	障害者手帳
何の制度か	介護サービス	障害福祉サービス	障害の証明・支援の入口
主な対象	65歳以上、または40～64歳で特定疾病	身体・知的・精神・発達障害、難病等	身体・知的・精神障害
判定・認定	要介護・要支援認定	障害支援区分、支給決定	障害程度・等級など
医師の関与	主治医意見書	医師意見書、診断書等	診断書・意見書
ポイント	高齢・加齢関連の介護ニーズ	障害特性に応じた生活・社会参加支援	手帳＝サービスそのものではない

身体障害者手帳

- 医師の診断書が必要
- 医師の指定は、医療機関の所在地別に、都道府県知事（指定都市市長、中核市長を含む。）が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。
- 名古屋市では、年3回（6月・10月・2月）、名古屋市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会・審査部会を開催し、その意見を聴いた上で、指定を実施。

指定医の基準（一部）

- 都道府県知事が法第15条第1項に規定する医師を指定する場合には、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能障害、音声、言語若しくはそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう若しくは直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又は肝臓機能障害の医療に関係のある診療科名を標榜している病院又は診療所において診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有する医師について行うものとする。

指定基準（名古屋市の場合）

- 平成21年12月24日障発1224第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」に定める要件を満たしている医師であって、次のいずれにも該当する方に対し、原則として一つの診断科目を指定します。
- 現に病院又は診療所において診療に従事していること。
- 診断を希望する科目に関する臨床経験が5年以上あること。
- 診断を希望する科目に係る学会、研究会に相当年数加入し、学会等に提出した論文が相当数あること。（例：「肢体不自由」の診断科目を希望する場合 日本神経内科学会、日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会など）

精神保健福祉手帳

- 医師の診断書が必要
- 診断書を記載する医師は、原則として精神保健指定医又は精神科医とするが、てんかんの患者について内科医が主治医となっている場合のように、精神科以外の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事していると言える医師は含まれる。

難病指定医（新規申請用・更新申請用のいずれの診断書も作成可能な医師）の要件

以下の（１）、（２）の要件を満たし、かつ（３）又は（４）のどちらかを満たすこと。

- （１） 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
- （２） 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
- （３） 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること
- （４） 知事が行う研修を修了していること

難病指定医

- 難病医療費助成制度
- 難病患者が制度の支給認定を受けるためには、知事の指定を受けた医師（指定医）が作成した診断書を添えて申請する